КУРС ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ ФЕДЕРАЦИИ ПАРКУРА АРМЕНИИ

Отдельный обучающий модуль (обязательный для всех тренеров)

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Назначение модуля

Настоящий курс является обязательным для всех тренеров Федерации паркура Армении (1-я, 2-я, 3-я категории). Без действующего сертификата о прохождении курса первой помощи тренер не допускается к проведению тренировок.

Цели курса

1. Научить тренера оценивать состояние пострадавшего за 30–60 секунд
2. Дать практические навыки оказания первой помощи при специфических травмах паркура
3. Научить отличать легкие травмы от тяжелых (когда можно продолжить тренировку, а когда — срочно вызывать скорую)
4. Сформировать алгоритм действий в стрессовой ситуации
5. Подготовить к сдаче сертификационного экзамена

Принципы первой помощи

1. Безопасность спасателя прежде всего — ты не поможешь, если сам станешь пострадавшим
2. Не навреди — если не уверен, делай минимум (вызови скорую, успокой, не перемещай)
3. Алгоритм важнее импровизации — действуй по шагам, не паникуй
4. Время — критично — первые 5–10 минут определяют исход
5. Документируй — фиксируй всё для отчета и расследования

Требования к сертификации

- Первичное обучение: 16 часов (теория + практика)

- Экзамен: письменный тест (80% правильных ответов) + практические сценарии
- Сертификат: действует 2 года
- Обновление: каждые 2 года — 8-часовой курс повторения + пересдача теста
- Без действующего сертификата: тренер отстраняется от работы с учениками

РАЗДЕЛ 1. СПЕЦИФИКА ТРАВМ В ПАРКУРЕ

1.1. Самые частые травмы (статистика)

По данным международных исследований (Pagnon et al., 2022; Strafford et al., 2022):

Тип травмы	% от всех травм	Типичная ситуация
Растяжение голеностопа	25–30%	Неудачное приземление с прыжка, подворот стопы
Ушибы и ссадины	20%	Падение на препятствие, столкновение
Рассечения	10–15%	Падение на острый край, контакт с металлом
Растяжение связок колена	8–10%	Резкая смена направления, неудачный приземление
Вывихи (пальцы, плечо)	5–8%	Зацеп за рейл, неудачный cat leap
Переломы (предплечье, ключица)	5%	Падение на вытянутую руку

Сотрясение мозга	3–5%	Удар головой о препятствие, падение с высоты
Травмы позвоночника	1–2%	Падение с высоты на голову/спину

1.2. Факторы риска в паркуре

1. Высота — падения с 1.5м+ увеличивают риск серьезных травм в 5 раз
2. Скорость — чем быстрее движение, тем тяжелее последствия ошибки
3. Усталость — 70% травм происходит во второй половине тренировки
4. Плохое покрытие — бетон, мокрый металл, скользкие рейлы
5. Недостаточная разминка — холодные мышцы и связки рвутся легче
6. Психологический фактор — страх, спешка, желание "впечатлить"

1.3. Что тренер должен помнить

- Ты не врач. Твоя задача — стабилизировать, не ухудшить, вызвать помощь.
- Не ставь диагноз. Говори "подозрение на перелом", а не "у него перелом".
- Не вправляй. Никогда не пытайся вправить вывих или перелом.
- Не давай лекарства без согласия пострадавшего/родителей и знания аллергий.
- Фиксируй всё. Время, обстоятельства, действия — для отчета.

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО (АЛГОРИТМ MARCH)

2.1. Первичный осмотр (30–60 секунд)

Используй алгоритм MARCH (Military/Tactical First Aid — адаптирован для спорта):
M — Massive Hemorrhage (Массивное кровотечение)

- Есть ли сильное, пульсирующее кровотечение?
- Если ДА → немедленно остановить (см. Раздел 6)

A — Airway (Дыхательные пути)

- Пострадавший в сознании? Говорит?

- Если без сознания → проверить, дышит ли (смотреть на грудь, слушать дыхание, чувствовать щекой)
- Если не дышит → СЛР (см. Раздел 5)

R — Respiration (Дыхание)

- Дышит ли нормально? Нет ли хрипов, пены, крови изо рта?
- Если затрудненное дыхание → положение полусидя, вызвать скорую

C — Circulation (Кровообращение)

- Есть ли признаки шока? (бледность, холодный пот, слабый пульс, спутанность сознания)
- Если ДА → уложить, приподнять ноги, вызвать скорую

H — Hypothermia / Head (Гипотермия / Голова)

- Есть ли признаки травмы головы? (потеря сознания, тошнота, разные зрачки, кровотечение из ушей/носа)
- Есть ли переохлаждение? (дрожь, бледная холодная кожа)

2.2. Вторичный осмотр (2–5 минут)

После стабилизации критических состояний — детальный осмотр:

1. Опрос пострадавшего (если в сознании):
    - "Что болит?"
    - "Как это произошло?"
    - "Были ли подобные травмы раньше?"
    - "Есть ли аллергии? Хронические заболевания?"
2. Визуальный осмотр:
    - Деформации конечностей (признак перелома/вывиха)
    - Отеки, гематомы
    - Раны, кровотечения
    - Асимметрия (например, одно плечо выше другого — подозрение на вывих ключицы)
3. Пальпация (осторожно!):
    - Найти точку максимальной боли
    - Проверить крепитацию (хруст — признак перелома)
    - Проверить пульс ниже травмы (если нет — срочная госпитализация)
4. Проверка подвижности:
    - Попросить пострадавшего пошевелить пальцами, стопой
    - Если не может — подозрение на перелом/повреждение нервов

РАЗДЕЛ 3. ТРАВМЫ ГОЛОВЫ: СОТРЯСЕНИЕ VS УШИБ

3.1. Как отличить сотрясение мозга от обычного ушиба

Это КРИТИЧНО. Сотрясение — это легкая черепно-мозговая травма. Пропущенное сотрясение может привести к тяжелым последствиям (вплоть до смерти при повторной травме).

Признак	Ушиб головы (легкая травма)	Сотрясение мозга
Потеря сознания	Нет	Может быть (от нескольких секунд до 10–15 минут)
Тошнота/рвота	Нет	Часто (особенно в первые 30 минут)
Головная боль	В месте удара	Разлитая, сильная, нарастающая
Головокружение	Нет или легкое	Сильное, не проходит
Зрачки	Одинаковые	Могут быть разными (анизокория)
Нарушение координации	Нет	Шаткая походка, не может встать на одну ногу
Нарушение речи	Нет	Заторможенная речь, не может ответить на простые вопросы
Кровотечение из ушей/носа	Нет	Может быть (признак тяжелого ЧМТ)
Поведение	Обычное	Сонливость, апатия, агрессия, спутанность

Память	Сохранена	Может не помнить, что произошло (ретроградная амнезия)

3.2. Тест на сотрясение (Maddocks Questions)

Задай пострадавшему эти 5 вопросов (занимает 1 минуту):

1. "В каком мы сейчас месте?" (зал, улица, город)
2. "Какой сейчас счет / минута тренировки?"
3. "Что ты делал до удара?" (какой элемент)
4. "Получил ли ты удар в голову в этой тренировке ранее?"
5. "Как ты себя чувствуешь?"

Если не может ответить правильно на 2+ вопроса → подозрение на сотрясение → ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ.

3.3. Первая помощь при подозрении на сотрясение

Шаг 1: Немедленно прекратить тренировку.
Шаг 2: Уложить пострадавшего с приподнятой головой (30°).
Шаг 3: Приложить холод к месту удара (лед в ткани на 15–20 минут).
Шаг 4: НЕ давать есть/пить/лекарства.
Шаг 5: Вызвать скорую (103), даже если состояние кажется стабильным.
Шаг 6: Наблюдать за сознанием и дыханием до приезда скорой.
Шаг 7: Уведомить родителей (если ребенок) или родственников.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ:

- Оставлять пострадавшего одного
- Давать спать (может впасть в кому)
- Давать обезболивающие (маскируют симптомы)
- Возвращать к тренировке в тот же день
- Игнорировать "он просто устал"

3.4. Возвращение к тренировкам после сотрясения

Только после медицинского заключения! Обычно:

- 1–2 недели полного покоя (никаких тренировок)
- Постепенное возвращение: ходьба → легкий бег → тренировка без контакта → полная тренировка
- При повторных симптомах (головная боль, головокружение) — немедленно прекратить

РАЗДЕЛ 4. ТРАВМЫ СУСТАВОВ: ВЫВИХИ И РАСТЯЖЕНИЯ

4.1. Как отличить вывих от растяжения

Признак	Растяжение связок	Вывих
Боль	Умеренная, нарастающая	Острая, нестерпимая
Деформация сустава	Нет	Есть (видимое смещение)
Подвижность	Ограничена, но возможна	Практически невозможна
Отек	Нарастает постепенно (15–30 мин)	Быстрый, выраженный
Гематома	Может быть	Часто
Пружинящее сопротивление	Нет	Есть (при попытке движения)

4.2. Вывих голеностопа (самая частая травма в паркуре)

Типичная ситуация: Неудачное приземление с прыжка, подворот стопы на неровной поверхности.
Признаки:

- Острая боль в области лодыжки
- Быстрый отек
- Невозможность наступить на ногу
- Видимая деформация (стопа "вывернута")

Первая помощь:

1. Не двигать пострадавшего, не пытаться "вправить".
2. Уложить, приподнять ногу (на рюкзак, куртку).
3. Холод на 15–20 минут (лед в ткани, не на кожу!).
4. Давящая повязка эластичным бинтом (не туго! Проверить пульс на стопе).

5. Иммобилизация — если есть шина, зафиксировать голеностоп. Если нет — бинт "восьмеркой".
6. Обезболивающее (ибупрофен) — только с согласия пострадавшего/родителей, без аллергии.
7. Вызвать скорую или доставить в травмпункт (не самостоятельно, если сильная боль).

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ:

- Пытаться вправить вывих самостоятельно
- Греть место травмы (усилит отек)
- Массировать
- Заставлять "походить, чтобы разработать"

4.3. Вывих плеча

Типичная ситуация: Падение на вытянутую руку, неудачный cat leap, срыв с рейла.
Признаки:

- Острая боль в плече
- Видимая деформация (плечо "запало" или "выпятилось")
- Невозможность двигать рукой
- Рука в вынужденном положении (обычно отведена и слегка согнута)
- Онемение пальцев (признак сдавления нерва)

Первая помощь:

1. Не двигать руку, не пытаться вправить.
2. Зафиксировать в том положении, в котором она находится:
    - Подложить под руку валик (свернутую куртку).
    - Прибинтовать к туловищу (косынка, шарф, ремень).
3. Холод на плечо на 15–20 минут.
4. Обезболивающее (с согласия).
5. Вызвать скорую — вывих плеча требует вправления в условиях стационара.

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ:

- Пытаться вправить плечо (можно повредить сосуды и нервы)
- Тянуть за руку
- Оставлять без иммобилизации

4.4. Вывих пальца (очень частая травма в паркуре)

Типичная ситуация: Зацеп за рейл, неудачный хват на стене, падение на руку.
Признаки:

- Острая боль в пальце
- Деформация (палец "сложен" под углом)
- Отек, гематома
- Невозможность согнуть/разогнуть

Первая помощь:

1. Не вправлять (если нет опыта и это не твой палец).
2. Холод на 10–15 минут.
3. Иммобилизация — прибинтовать палец к соседнему (тейп или бинт).
4. Обезболивающее.
5. Доставить в травмпункт (вправление должно быть сделано врачом с рентгеном).

Исключение: Если ты сам опытный трейсер и у тебя был подобный вывих, ты можешь аккуратно вправить свой палец (потянуть по оси и согнуть). Но это только для себя, не для учеников!

4.5. Растяжение связок колена

Типичная ситуация: Резкая смена направления, неудачное приземление с поворотом.
Признаки:

- Боль в колене (с внутренней или внешней стороны)
- Отек (нарастает в течение 1–2 часов)
- Ощущение "нестабильности" колена
- Хруст в момент травмы (признак разрыва связки)

Первая помощь (протокол RICE):

- R — Rest (Покой): Прекратить нагрузку, не наступать на ногу.
- I — Ice (Холод): Лед на 15–20 минут, повторять каждые 2 часа.
- C — Compression (Давление): Эластичный бинт (не туго!).
- E — Elevation (Поднятие): Приподнять ногу выше уровня сердца.

Когда вызывать скорую:

- Невозможно наступить на ногу
- Быстрый, выраженный отек
- Видимая деформация
- Онемение стопы

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЛОМЫ

5.1. Как отличить перелом от ушиба/растяжения

Признак	Ушиб/растяжение	Перелом
Боль	Умеренная, нарастающая	Острая, нестерпимая, усиливается при движении
Осевая нагрузка	Терпима	Резкая боль при нагрузке по оси конечности
Крепитация	Нет	Есть (хруст отломков при пальпации)
Деформация	Нет (только отек)	Есть (укорочение, угол, ротация)
Подвижность	Сохранена	Патологическая (движение там, где нет сустава)
Функция	Ограничена	Полностью утрачена

5.2. Закрытый перелом

Признаки:

- Боль, отек, гематома
- Деформация конечности
- Патологическая подвижность
- Крепитация (хруст)
- Невозможность использовать конечность

Первая помощь:

1. Не двигать пострадавшего, не пытаться выпрямить конечность.
2. Иммобилизация шиной (или подручными средствами):
    - Зафиксировать два соседних сустава (выше и ниже перелома).
    - Например, при переломе предплечья — фиксировать локтевой и лучезапястный суставы.
    - Шина должна быть длиннее конечности.
    - Подложить мягкую ткань под шину.

    - Забинтовать, но не туго (проверить пульс ниже!).
3. Холод на место перелома.
4. Обезболивающее (с согласия).
5. Вызвать скорую.
6. При переломе ноги — не наступать, транспортировать лежа.

Подручные средства для шин:

- Доска, палка, зонт
- Картон, свернутый журнал
- Собственная рука (прижать к туловищу)
- Собственная нога (привязать к здоровой)

5.3. Открытый перелом

Признаки:

- Все признаки закрытого перелома +
- Рана, видны костные отломки
- Кровотечение

Первая помощь:

1. НЕ трогать выступающие кости! НЕ вправлять!
2. Накрыть рану стерильной повязкой (не давящей!).
3. Иммобилизация в том положении, в котором находится конечность.
4. Остановка кровотечения (см. Раздел 6) — если сильное.
5. Обезболивающее.
6. Вызвать скорую НЕМЕДЛЕННО.
7. Приподнять конечность (если нет травмы позвоночника).

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ:

- Трогать рану руками (только через перчатки/стерильную салфетку)
- Пытаться вправить кости
- Промывать рану (только вокруг)
- Давать пить при подозрении на операцию (может понадобиться наркоз)

5.4. Подозрение на перелом позвоночника

Это САМАЯ ОПАСНАЯ травма. Неправильные действия могут привести к пожизненному параличу.
Типичные ситуации в паркуре:

- Падение с высоты на голову/спину
- Удар головой о препятствие при неудачном ролле
- Падение на спину с большой высоты

Признаки:

- Боль в спине/шее
- Невозможность двигаться
- Онемение или покалывание в конечностях
- Слабость в руках/ногах
- Нарушение дыхания
- Потеря сознания

Первая помощь:

1. НЕ ПЕРЕМЕЩАТЬ пострадавшего! (кроме случаев непосредственной угрозы жизни — пожар, обрушение).
2. Зафиксировать голову и шею валиками из одежды с обеих сторон.
3. Успокоить пострадавшего, запретить двигаться.
4. Вызвать скорую НЕМЕДЛЕННО.
5. Контролировать дыхание и сознание до приезда скорой.
6. Если пострадавший без сознания и дышит — устойчивое боковое положение (только если есть помощники для фиксации шеи!).

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ:

- Сажать, ставить, перемещать
- Пытаться "проверить, может ли он встать"
- Тянуть за руки/ноги
- Давать пить/есть

РАЗДЕЛ 6. КРОВОТЕЧЕНИЯ

6.1. Виды кровотечений

Вид	Признаки	Опасность
Капиллярное	Кровь сочится, как из губки	Низкая (ссадины)
Венозное	Кровь темная, течет равномерно	Средняя/высокая
Артериальное	Кровь алая, бьет пульсирующей струей	КРИТИЧЕСКАЯ (смерть за 2–3 минуты)

6.2. Алгоритм остановки кровотечения

Шаг 1: Надеть перчатки (если есть).
Шаг 2: Прижать рану стерильной салфеткой/чистой тканью.
Шаг 3: Наложить давящую повязку (эластичный бинт, но не жгут!).
Шаг 4: Приподнять конечность выше уровня тела (если нет перелома).
Шаг 5: НЕ снимать первую повязку — если пропиталась кровью, накладывать поверх.
Шаг 6: При артериальном кровотечении — жгут ВЫШЕ раны.

6.3. Наложение жгута

Когда применять: Только при сильном артериальном кровотечении, которое не останавливается давящей повязкой.
Правила:

1. Жгут накладывается выше раны на 5–10 см (на одежду или ткань, не на кожу).
2. Зафиксировать время наложения (написать на лбу пострадавшего или на жгуте: "ЖГУТ 14:35").
3. Максимальное время:
    - Летом: 1.5–2 часа
    - Зимой: 1–1.5 часа
4. НЕ ослаблять жгут до приезда скорой (это может вызвать повторное кровотечение).
5. Обезболить (жгут вызывает сильную боль).

Подручные средства для жгута:

- Ремень, шарф, галстук (шириной 3–5 см)
- НЕ использовать: тонкую веревку, провод (врезаются в ткани)
- Метод закрутки: палка + ткань, закручивать до остановки кровотечения

6.4. Носовое кровотечение

Типичная ситуация: Удар в нос, падение лицом.
Первая помощь:

1. Усадить пострадавшего, наклонить голову ВПЕРЕД (НЕ назад!).
2. Прижать крылья носа к перегородке на 10 минут (не отпускать проверять!).
3. Приложить холод на переносицу.
4. Если не останавливается >20 минут — вызвать скорую.

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ:

- Запрокидывать голову назад (кровь потечет в желудок, вызовет рвоту)

- Закладывать вату в нос (потом будет больно вытаскивать)
- Сморкаться

РАЗДЕЛ 7. СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ (СЛР)

7.1. Когда применять СЛР

- Пострадавший без сознания
- Не дышит или дышит агонально (редкие, судорожные вдохи)
- Нет пульса на сонной артерии (проверка 10 секунд)

7.2. Алгоритм СЛР (по стандартам ERC 2021)

Шаг 1: Проверить безопасность (нет ли угрозы для тебя).
Шаг 2: Проверить сознание — громко окликнуть, потрясти за плечи.
Шаг 3: Позвать на помощь — "Кто-нибудь, вызовите скорую! Принесите АНД!"
Шаг 4: Открыть дыхательные пути — запрокинуть голову, поднять подбородок.
Шаг 5: Проверить дыхание (10 секунд) — смотреть на грудь, слушать, чувствовать щекой.
Шаг 6: Если не дышит — начать СЛР.
Компрессии грудной клетки:

- Место: центр грудной клетки (нижняя половина грудины)
- Положение рук: основание ладони одной руки на грудине, вторая рука сверху, пальцы в замок
- Глубина: 5–6 см (у взрослых)
- Частота: 100–120 компрессий в минуту (ритм песни "Stayin' Alive" Bee Gees)
- Позволить грудной клетке полностью расправиться после каждой компрессии

Искусственное дыхание (если обучен):

- После 30 компрессий — 2 вдоха
- Запрокинуть голову, зажать нос, сделать вдох в рот (грудь должна подняться)
- Если не обучен или не уверен — только компрессии (это тоже эффективно!)

Цикл: 30 компрессий → 2 вдоха → продолжать до:

- Прибытия скорой

- Появления признаков жизни (дыхание, движение)
- Твоего полного истощения
- Появления АНД

7.3. Использование АНД (автоматического наружного дефибриллятора)

АНД — это просто. Аппарат сам говорит, что делать.
Алгоритм:

1. Включить АНД.
2. Приклеить электроды по схеме (на аппарате нарисовано).
3. АНД анализирует ритм — НЕ ТРОГАТЬ пострадавшего.
4. Если АНД говорит "Разряд необходим" — убедиться, что никто не касается пострадавшего, нажать кнопку разряда.
5. Продолжить СЛР после разряда.
6. Следовать голосовым командам АНД.

РАЗДЕЛ 8. ШОК

8.1. Виды шока в паркуре

- Гиповолемический — от кровопотери
- Травматический — от сильной боли и травмы
- Анафилактический — от аллергической реакции

8.2. Признаки шока

- Бледная, холодная, влажная кожа
- Слабый, частый пульс (>100 уд/мин)
- Частое, поверхностное дыхание
- Спутанность сознания, тревога
- Тошнота, рвота
- Жажда
- Снижение артериального давления

8.3. Первая помощь при шоке

1. Устранить причину (остановить кровотечение, обезболить).
2. Уложить, приподнять ноги на 30–50 см (если нет травмы головы/позвоночника).
3. Согреть (одеяло, куртка) — даже летом.
4. Успокоить, разговаривать.
5. НЕ давать пить/есть (может понадобиться наркоз).

6. Вызвать скорую.
7. Контролировать дыхание и сознание.

РАЗДЕЛ 9. ТЕПЛОВОЙ УДАР И ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ

9.1. Тепловой удар

Типичная ситуация: Тренировка на улице в жару (>30°C), недостаточное питье.
Признаки:

- Температура тела >40°C
- Красная, горячая, сухая кожа (пот прекратился!)
- Сильная головная боль
- Тошнота, рвота
- Спутанность сознания, потеря сознания
- Учащенный пульс

Первая помощь:

1. Переместить в прохладное место (тень, помещение).
2. Снять лишнюю одежду.
3. Охлаждать:
    - Мокрые холодные полотенца на шею, подмышки, пах
    - Обдувать вентилятором
    - Обтирать холодной водой
4. Если в сознании — давать пить прохладную воду маленькими глотками.
5. Если потеря сознания — вызвать скорую, устойчивое боковое положение.

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ:

- Опускать в ледяную воду (спазм сосудов)
- Давать алкоголь, кофе
- Растирать кожу спиртом

9.2. Переохлаждение

Типичная ситуация: Тренировка на улице в холод/дождь, падение в воду.
Признаки:

- Дрожь (в легкой стадии)
- Бледная, холодная кожа
- Замедленная речь, спутанность сознания
- Сонливость

- В тяжелой стадии — дрожь прекращается, потеря сознания

Первая помощь:

1. Переместить в теплое место.
2. Снять мокрую одежду.
3. Укутать в теплое одеяло (включая голову).
4. Дать теплое сладкое питье (если в сознании).
5. Приложить теплое (не горячее!) к шее, подмышкам, паху.

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ:

- Растирать кожу (повреждает ткани)
- Использовать горячую воду/грелки (шок для сосудов)
- Давать алкоголь (расширяет сосуды, усиливает потерю тепла)
- Заставлять двигаться

РАЗДЕЛ 10. ПРАКТИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ (ДЛЯ ОТРАБОТКИ)

Сценарий 1: Падение с тумбы

Ситуация: Ученик (14 лет) делает Kong vault на тумбу 80 см, не рассчитывает, падает на вытянутую руку. Жалуется на острую боль в предплечье. Видна деформация, быстро нарастает отек.
Задание для тренера:

1. Оценить состояние (алгоритм MARCH).
2. Определить тип травмы.
3. Оказать первую помощь.
4. Принять решение о вызове скорой.
5. Зафиксировать инцидент.

Правильные действия:

- Остановить тренировку.
- Успокоить ученика, уложить/усадить.
- Не двигать руку, зафиксировать в текущем положении (косынка, прибинтовать к туловищу).
- Приложить холод.
- Вызвать скорую (подозрение на перелом).
- Уведомить родителей.
- Заполнить отчет о ЧП.

Сценарий 2: Удар головой

Ситуация: Ученик (12 лет) делает ролл, но не докручивает, ударяется головой о мат. Встает, говорит "нормально", но через 5 минут жалуется на головную боль и тошноту.
Задание:

1. Провести тест на сотрясение (Maddocks Questions).
2. Оказать первую помощь.
3. Принять решение о дальнейших действиях.

Правильные действия:

- Прекратить тренировку.
- Провести тест: ученик не помнит, какой элемент делал, не может ответить на 2 вопроса.
- Уложить с приподнятой головой.
- Приложить холод.
- Вызвать скорую (подозрение на сотрясение).
- Уведомить родителей.
- НЕ возвращать к тренировке в этот день.

Сценарий 3: Кровотечение

Ситуация: Ученик падает на острый край металлического рейла. Рассечение предплечья, кровь темная, течет равномерно.
Задание:

1. Оценить тип кровотечения.
2. Оказать первую помощь.

Правильные действия:

- Венозное кровотечение (темная кровь, течет равномерно).
- Надеть перчатки.
- Прижать рану стерильной салфеткой.
- Наложить давящую повязку.
- Приподнять конечность.
- Если не останавливается — вызвать скорую.
- Уведомить родителей.

Сценарий 4: Потеря сознания

Ситуация: Ученик (16 лет) после интенсивной тренировки в жарком зале внезапно теряет сознание.
Задание:

1. Оценить состояние.

2. Оказать первую помощь.

Правильные действия:

- Проверить сознание — не реагирует.
- Проверить дыхание — дышит.
- Проверить пульс — есть.
- Уложить на спину, приподнять ноги.
- Расстегнуть тесную одежду.
- Обеспечить приток воздуха.
- Поднести нашатырь (на расстоянии 1–2 см).
- После прихода в сознание — дать сладкий чай.
- Выяснить причину (обезвоживание, гипогликемия, переутомление).
- Уведомить родителей.
- Если не приходит в сознание >1 минуты — вызвать скорую.

Сценарий 5: Остановка дыхания

Ситуация: Ученик упал с высоты 3 м, ударился головой. Без сознания, не дышит.
Задание:

1. Оценить состояние.
2. Начать СЛР.

Правильные действия:

- Проверить сознание — нет.
- Проверить дыхание — нет.
- Позвать на помощь: "Вызовите скорую! Принесите АНД!"
- Открыть дыхательные пути (запрокинуть голову).
- Начать СЛР: 30 компрессий → 2 вдоха.
- Продолжать до прибытия скорой или появления признаков жизни.
- Использовать АНД, когда принесут.

РАЗДЕЛ 11. АПТЕЧКА ТРЕНЕРА (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ)

11.1. Минимальный состав (на группу 10 человек)

Перевязочные материалы:

- Бинт стерильный 7 м × 14 см — 5 шт
- Бинт нестерильный 5 м × 10 см — 5 шт

- Салфетки марлевые стерильные — 20 шт
- Пластырь бактерицидный (разных размеров) — 20 шт
- Пластырь рулонный — 2 шт
- Эластичный бинт 7 м × 10 см — 3 шт
- Косынка (для подвешивания руки) — 2 шт

Антисептики:

- Хлоргексидин 0.05% (100 мл) — 2 флакона
- Перекись водорода 3% (100 мл) — 1 флакон

Средства для иммобилизации:

- Шина транспортная пластиковая — 2 шт
- Ножницы медицинские — 1 шт

Прочее:

- Перчатки медицинские стерильные — 5 пар
- Маска для искусственного дыхания — 2 шт
- Термометр — 1 шт
- Нашатырный спирт (10 мл) — 5 ампул
- Холодный спрей/пакет — 5 шт
- Ожоги.нет (гель) — 1 тюбик
- Спасательное одеяло (термопокрывало) — 3 шт

Лекарства (только с согласия пострадавшего/родителей):

- Ибупрофен 400 мг — 1 упаковка
- Парацетамол 500 мг — 1 упаковка
- Супрастин/Зодак (антигистаминное) — 1 упаковка
- Автоинжектор адреналина (EpiPen) — если у ученика аллергия (по показаниям)

11.2. Проверка аптечки

- Перед каждой тренировкой: наличие, комплектация
- После использования: немедленное пополнение
- Раз в месяц: проверка сроков годности
- Ответственный: тренер / Ответственный за безопасность

РАЗДЕЛ 12. ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Вопросы (выберите правильный ответ)

1. При подозрении на сотрясение мозга тренер должен:
а) Дать обезболивающее и вернуть к тренировке
б) Прекратить тренировку, приложить холод, вызвать скорую
в) Уложить спать
г) Дать попить воды и посмотреть, как себя чувствует
2. При артериальном кровотечении жгут накладывается:
а) На рану
б) Ниже раны
в) Выше раны на 5–10 см
г) В любом месте конечности
3. При подозрении на перелом позвоночника:
а) Посадить пострадавшего
б) Дать походить, чтобы проверить
в) Не перемещать, зафиксировать голову, вызвать скорую
г) Вправить позвонки
4. При носовом кровотечении голову нужно:
а) Запрокинуть назад
б) Наклонить вперед
в) Повернуть в сторону
г) Оставить прямо
5. Глубина компрессий грудной клетки при СЛР у взрослого:
а) 2–3 см
б) 5–6 см
в) 8–10 см
г) 1 см
6. При вывихе плеча:
а) Вправить самостоятельно
б) Тянуть за руку
в) Зафиксировать в текущем положении, приложить холод, вызвать скорую
г) Дать разработать
7. При тепловом ударе:
а) Опустить в ледяную воду
б) Охлаждать мокрыми полотенцами на шею, подмышки, пах
в) Дать алкоголь
г) Растирать спиртом
8. При открытом переломе:
а) Вправить кости
б) Промыть рану
в) Накрыть стерильной повязкой, не трогать кости, вызвать скорую
г) Зашить рану
9. Время наложения жгута летом:
а) 30 минут
б) 1.5–2 часа
в) 4 часа

г) Не имеет значения
10. При потере сознания, но наличии дыхания:
а) Уложить на спину
б) Уложить в устойчивое боковое положение
в) Посадить
г) Дать понюхать нашатырь и оставить одного

Ответы

1 — б
2 — в
3 — в
4 — б
5 — б
6 — в
7 — б
8 — в
9 — б
10 — б
Проходной балл: 8 из 10 правильных ответов (80%).

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАТУ

13.1. Первичное обучение

- Объем: 16 часов (8 часов теории + 8 часов практики)
- Содержание: все разделы данного модуля
- Экзамен:
    - Письменный тест (30 вопросов, 80% правильных)
    - Практические сценарии (5 ситуаций, оценка комиссии)
- Сертификат: действует 2 года

13.2. Обновление (каждые 2 года)

- Объем: 8 часов (4 часа теории + 4 часа практики)
- Содержание: повторение ключевых тем, новые протоколы, разбор реальных случаев
- Экзамен:
    - Письменный тест (20 вопросов, 80% правильных)
    - Практический сценарий (1 ситуация)
- Продление сертификата: еще на 2 года

13.3. Отстранение от работы

Тренер не допускается к проведению тренировок, если:

- Сертификат просрочен
- Не сдан экзамен при первичном обучении
- Не прошел обновление в течение 2 лет
- Допущены грубые ошибки при оказании первой помощи (по результатам разбора инцидента)

13.4. Ответственность

Тренер несет дисциплинарную и юридическую ответственность за:

- Неоказание первой помощи при ЧП
- Неправильные действия, усугубившие травму
- Отсутствие аптечки на тренировке
- Незнание алгоритмов первой помощи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Этот курс — не формальность. Это навык, который спасает жизни. В паркуре травмы случаются, и тренер часто оказывается единственным, кто может помочь в первые критические минуты.
Помни:

- Не паникуй. Алгоритм важнее импровизации.
- Не навреди. Если не уверен — вызови скорую, не двигай пострадавшего.
- Действуй быстро. Первые 5–10 минут определяют исход.
- Документируй. Фиксируй всё для отчета.
- Обновляй знания. Медицина меняется, протоколы обновляются.